

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO ( ) CONSULTA

NS 22222395789

880

**JOSEFINA LEONOR DAMIAO DE FARIA**IDADE: 74 PESO: 87 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: DO lar; *sempre Acompanhada*SINTOMAS: Tontura  $\rightarrow$  *degarde timpano??* *à noite sozinho*

QUEIXAS: Ronco; Sono leve diurna; reflexo.

MEDICAMENTOS: Dexilant; Duloxetine; Doraven. (Praxipatia); *homocistina*MÉDICO: *Dr Ricardo Placido / garha.*

MARCAPASSO: ( ) S ( ) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ( ) S ( ) N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA:

COCHILO: ☒ S ( ) NDORME ACOMPANHADO: ( ) S ☒ N ( ) EVENTUALMENTE*Viuve*TEM FILHOS: ☒ S ( ) N

DORMEM NO QUARTO: ( ) S ( ) N

PET NO QUARTO: ( ) S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ( ) S ( ) X NA SEMANA ☒ NFUMO: ( ) S ( ) MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: *Sim*

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: *90e/h*

SPO2: 73%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

*SPO2 méd: 88%.*

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: *Dr na PSG com PLM 0%: 4 despertares 62/h*

COMORBIDADE: ( ) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

( ) ORTOPÉDICA

( ) NEUROLÓGICA

( ) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ( ) S ( ) N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

*24/03/25. Avaliação Elite P: 7,0 cmH2O**(perdeu o filho no Covid.)**marc Dream Wear (M)**25/03/25 P=7,4 cmH2O**P 7,6 cmH2O**IAH: 5,2 e/h**mda ura: 7h38'**pressão: 25,8 mm**ajuste o Oxiator praxipatia marcava.**Natasha.*

08/05/25 P=7,6aulh20

IAH=1,2 e/h

mdew: 5h39'

fuga: 9,7llm

Compro CPAP Elite

Bem adaptada

3/ queiros

Natacha

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**90,5 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina normal (**73%**);
3. Latência para o início do sono normal (**2,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (**86,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (**83,9 %**) (VN=  $\geq 85\%$ );
6. Aumento do índice de despertares (**62,0 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**75,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**4,5 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (**18,0 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco moderado, constante, verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

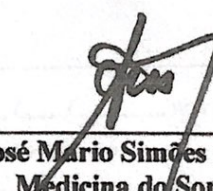
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
**Dr. José Mario Simões da Costa**  
Medicina do Sono  
CRM 57157

Nome: JOSEFINA LEONOR DAMIAO DE FARIA

Data do Exame: 19-02-2025